



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : هديه اسماعيل محمد فرجاني

العنوان : البدرشين

الحي / المدينة : البدرشين

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

رقم البطاقة : 27702022101184 رقم التليفون : 01280703860

العمر (تاريخ الميلاد) : 02-02-1977 المهنة : كهربائي سيارات

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: التوقيع:
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هديه اسماعيل محمد فرجاني National ID: 27702022101184	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



مركز دكتور أحمد أنور دبور
د / أحمد أنور دبور
استشاري الأشعة التشخيصية
رئيس قسم الأشعة بالمستشفى العام
معهد ناصر ٢٠٠٠ - ٢٠٠٦

جهاز مقطعية متعدد التشخيص
موجات صوتية قلب أطفال وكبار - دوبرلر ملون
ماموجرام على الثدي - بانوراما الاسنان ديجيتال
رسم مخ - خدمة مؤجلة متميزة
معمل تحاليل طبية
رسم عصب وعضلات - سونار رباعي الأنحاء
جهاز الـ 4D

Indyia Imani Moham	DATE	02	06	2006
Prof. Ahmed Abou-Samraa				

RIGHT BREAST EXAMINATION MAMMOGRAPHY & U.S.

Mammography:

- Radio-opaque lesion seen at upper lateral quadrant with articular distortion.
- Normal density of rest of the breast tissue.
- No evidence of micro or macro calcifications.
- Normal nipple and retro areolar area
- Normal overlying skin

Ultrasound:

- Hypo echoic mass lesion 1.7x1.6 cm with irregular border at 11o'clock
- Shows homogenous parenchymal echogenicity.
- Normal over lying skin.
- Normal Retroareolar area.
- Axillary L.N.: no suspicious Axillary L.N. could be detected.

Conclusion:

- Right breast suspicions lesion (BIRAD IV) for pathological assessment.

01123971066 - 0238034743
01128278313 - 01009934966 - 0238025132
01099447674
01090826805

بدرشين (١) ، شارع الدكتور أحمد دبور - بجوار بنك التنمية والإئتمان الزراعي
(٢) : الموقف الثاني - برج الهادي
جوامدية : شارع المجلس - برج البطيخ - الدور الثالث (قريباً) .
مزة : حارة النصر - الدور الثالث



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



Patient ID:
Name: هديه اسماعيل محمد فرجاني

Sex:

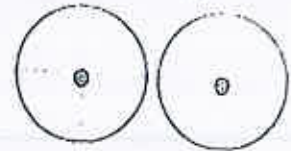
MDT form
3- Medical number:
Female

83167135
Old Med:

Old Med:
3813-2023

number: 27702022101184

Patient Age: 47 Y



Family history
-VE

Phone

Phone

01158563627

BMI

Marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

01151144820

GROUP

Co Morbidity
DM

Co Morbidity
DM

Menopausal
status

Menopausal Status
POSTMENOPAUSAL

REASON OF MDT

Date of MDT

Date of MDT

2023-10-21

Imaging:

Clinical data

Mets Workup :
pelvi abd U/S :free
chest x-ray :free

ER:
6/8

ER COMMENT:

PR:
4/8

PR COMMENT:

Her 2 Neu :
3

Her 2 Neu COMMENT:

SISH :

SISH COMMENT:

Ki67 :
50

N
0

M
0

Mammography

Mass 17 x 18 mm

PATIENT HISTORY

underwent upfront RT BCS+ALND (outside)

resected margin

ALND 0/12

OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

CTs, bone scan

Adjuvant taxol/3wks for 4 C (she is far resident) + herceptin for 1 y

then PORT and E2 now and ET accordingly (AI) zoladex if premenop

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

سليمه قنديل

SURGER

سليمه قنديل

Psychiatric

SIGNATURE

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

RADIOLOGY

سليمه قنديل

PATHOLOGY

سليمه قنديل

Nutrition

MDT Form

[DOCTYPE:MDT_FORM]

Name: هديه اسماعيل محمد		
MR. : 1865		
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient underwent an upfront breast-conserving surgery with axillary lymph node dissection (BCS + ALND) performed at an outside facility in October 2023, achieving free resection margins; pathology revealed 0 of 12 lymph nodes positive. Post-operative management included adjuvant weekly taxol administered every 3 weeks for a total of four cycles, followed by one year of trastuzumab (Herceptin). Subsequent treatment comprised postoperative radiotherapy (PORT) and ongoing endocrine therapy tailored to menopausal status, consisting of an aromatase inhibitor or zoladex if premenopausal, together with nolvadex and supportive care. The next follow-up appointment is scheduled for 23 September 2026. The patient has completed four cycles of adjuvant taxol.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	نهى سعيد علي محمد
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		



جهة الاصدار: فرع الجيزة

تاريخ الاصدار: 2023-11-25

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والا، امل " وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) هديه اسماعيل محمد فرجاني بطاقة رقم 27702022101184

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون اي مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2023-11-25



قاعدة مركز نظم المعلومات
يعتمد



مستسل 163872



الخطاب مملوك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار



Patient Name:	Hadeya Ismail mohammad Fergany	Patient Gender:	Female
Patient Code:	Q39460	DATE:	12/9/2023 11:05:08 AM

Tc⁹⁹ m MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

Clinical history

- Female patient with history of right breast cancer, for assessment.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post IV injection of 740 MBq of the tracer.

Findings

- No abnormal osseous tracer uptake is seen that would account for metastatic osseous lesions.
- Mild degenerative changes of the spine are seen.
- Osteoarthritic changes of knees are observed.

Opinion

- No scintigraphic evidence of metastatic osseous lesions.

Dr. Ferdaws Badr

Dr. Nahla Dessoki, MD

Patient Name: Hedeya Ismail Mohamed Fergani	Date : 18/11/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 3813/2023	

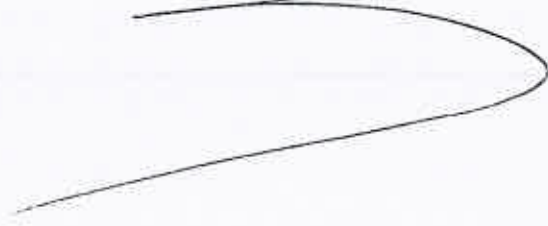
- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- *No evidence of pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.*

Dr. Wafaa Ali, MSc.

Dr. Ola Magdy, M.D.





Patient Name: Hedeia Ismail Mohamed Fergani	Date: 18/11/2023
Exam: CT CHEST WITH CONTRAST	Age: 46 Year(s)
Medical ID: 3813/2023	

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

1. Chest:

- Evidence of right breast and right axillary soft tissue sheets and scarring as well as thickened skin with bilateral nodular breast enhancement.
- Prominent right axillary lymph nodes.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Calcular G.B.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. The scanned skeleton:



Echo report

Name: د. اسحاق

Date: ٢٠٨١/ 2023

MR: ٢٠٨١٢
٢٤

EF	<u>68</u>	55-75%	PWT	<u>1.1</u>	
LVEDD	<u>4.53</u>	3.5-5.8cm	AO.R	<u>2.22</u>	2-3.7cm
LVESD	<u>2.76</u>	2-4cm	LA	<u>3.62</u>	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT		0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions Normal

LV wall thickness Normal

LV diastolic function diastolic dysfunction GI

SWMA No renal A

LA and Aortic root dimensions Normal

Mitral Valve degenerative mild MR

Aortic valve Normal morphology & excursion

Tricuspid valve Normal

Pulmonary valve Normal

Right side and systolic function Normal

Intracardiac masses and effusion No masses or effusion

D/ Msc cardiology

Dr. Asmaa
20/11/23



Patient Name: Hedeya Ismail Mohamed Fergani	Date: 18/11/2023
Exam: CT CHEST WITH CONTRAST	Age: 46 Year(s)
Medical ID: 3813/2023	

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- *No evidence of pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.*

Dr. Wafaa Ali, MSc.

Dr. Ola Magdy, M.D.

Patient Name: Hedeya Ismail Mohamed Fergani	Date : 18/11/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 3813/2023	

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

1. Chest:

- Evidence of right breast and right axillary soft tissue sheets and scarring as well as thickened skin with bilateral nodular breast enhancement.
- Prominent right axillary lymph nodes.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Calcular G.B.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. The scanned skeleton:



Patient Name:	Hadeya Ismail mohammad Fergany	Patient Gender:	Female
Patient Code:	Q39460	DATE:	12/9/2023 11:05:08 AM

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

Clinical history

- Female patient with history of right breast cancer, for assessment.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post IV injection of 740 MBq of the tracer.

Findings

- No abnormal osseous tracer uptake is seen that would account for metastatic osseous lesions.
- Mild degenerative changes of the spine are seen.
- Osteoarthritic changes of knees are observed.

Opinion

- No scintigraphic evidence of metastatic osseous lesions.

Dr. Ferdaws Badr

Dr. Nahla Dessoki, MD



CAIRO UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE
PATHOLOGY DEPARTMENT

Pathology No: 1995a

Name هدية اسماعيل محمد

Age: 46

Sex: female

Clinical diagnosis Right breast mass

Hospital_no: Gyna

Nature of specimen Breast conservative surgery

Department:

Date: 23/09/2023

PATHOLOGY REPORT

GROSS:

Fibrofatty tissue piece ; 7x4x4 cm covered by skin ; 7x2.5 cm, marked by (short, long, double) sutures for (superior, lateral, deep) margins respectively. The cut section showed an irregular firm gritty mass; 2.2x1.7 cm. Separate fibrofatty tissue measured ; 8x7x1.5 cm entangled 12 nodules with rubbery greyish white cut section, up to 3 cm in diameter.

MICROSCOPIC:

Examination of the mass revealed malignant tumor formed of groups & trabeculae of moderately to markedly anaplastic ductal epithelial cells within desmoplastic stroma. There is evidence of vascular emboli and perineural invasion. Necrosis was also detected. All resection margins were free of tumor.

The detected lymph nodes showed reactive lymph nodes, free of metastatic tumor (0/12).

DIAGNOSIS:

Invasive duct carcinoma, NST, grade III.

Free resection margin.

Free L.Ns (0/12).

P T2 N0 Mx

PROF. DR. SARA KHALIFA

Checked by: BY

Revised by:BY